EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 89968
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 05-08-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA EUGENIA MU►OZ MENDEZ			RUN	: 5.383.176-1
F.Nac	: 20-09-1941	Edad	: 82 AÑOS, 10 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: BILBAO 230 INTERIOR			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 985387806		
Fecha Ingreso	: 2024-07-29	Fecha Egreso	: 05-08-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. R57.2-CHOQUE SEPTICO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Insuficiencia respiratoria aguda
-Neumonía izquierda
-Derrame pleural masivo
ITU
Anemia moderada

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J90-DERRAME PLEURAL NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

AP: Dependencia severa, Demencia, Artrosis, HTA, Constipación
Alergia niega

Familiar de paciente refiere inicio de sintomatología hace 24 horas presentando exacerbación de accesos de tos, con mal manejo de secreciones, disnea y desaturando (mide en domicilio con oxímetro dando 57% sat), por lo que decide acudir a este centro.
Destaca desde hace 2 semanas hipoactividad, disminución progresiva de volumen urinario, y CEG.

Ex de laboratorio
EOC positivo con placas de pus. GB 25-50xc.
Crea 0.5, lactato 2.9, PCR 160, Hb 0, GB 25.
Se toma RX TX donde se evidencia franco derrame pleural izquierdo copuando casi la totalidad del campo pulmonar. Desviación de tráquea a la izquierda, escaso componente aéreo visible, broncogramas, reforzamiento pleural.

Ex físico
Piel: cambios y signos propios de la edad. Francos signos de fragilidad. Lesiones abrasivas simples, hematomas, ulceras, laceraciones múltiples.
CP: Torax asimétrico, hipoexpansible lado izquierdo, RSRSPS, abolidos 2/3 izquierdos, abundantes estertores. RSCSRSRS SS NG
Abd: RHA+, sin megalias, no impresiona doloroso.
Extremidades: aumento de volumen generalizado, impresiona edema por declive.
Se evidencian dos úlceras región posterior.
Neurológico: GSW no cuantificable, desconectada con el medio, apertura ocular espontánea, sin signos de focalización nuevos o irritación meníngea.

En vista de condiciones se decide ingreso a servicio

Durante estancia en servicio de medicina recibiendo terapia ATB con Ceftriaxona durante 8 días sin observar reacciones adversas o complicaciones.
Examenes de laboratorio control con parámetros inflamatorios bajos, persistiendo con anemia, con función renal conservada sin compromiso durante estancia.
Se toma UCT que reporta negativo.

En vista de mejoría clínica y ausencia de nuevo compromiso se decide derivar a domicilio para continuidad de terapia con HODOM. Dado compromiso se sugiere: 10 dias de terapia ATB hoy 8/10.

INDICACIONES AL ALTA

1. Derivo HDOM
2. Reposo en cama
3. Regimen por SNG según valoración nutricional
4. Ceftriaxona 2gr ev día (8/10)
5. Omeprazol 20mg vSNG dia
6. B ipratropio 4 puff c6h x AEC
7. Lactulosa 20cc c12h SOS
8. Fluconazol 200mg vSNG x 3 sem
9. Control SU SOS

EXÁMENES Y RESULTADOS

05/08/24 Crea: 0,30 | Clr MDRD: 212,98 | ProC: 62,2 | Uremia: 27 | Na: 133,00 | K: 4,60 | Cl: 104,00 | Hb: 8,2 | HTO: 25,8 | GB: 7,70 | Plaq: 346 | Seg: 65 | Linf: 26 | Mon: 6 | Eos: 2 | Bas: 1 | INR: 1,13 | TP%: 83 | TP seg: 15,0.

RX 05/08: Disminución franca de compromiso pulmonar izquierdo.

UCT: Reporta negativo

andres david velasquez guerra
MEDICO TRATANTE
27124399-5

JEFE SERVICIO